



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : فوزيه شاذلي خلف الله حسن
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : شبرا
رقم البطاقة : 25601220103984 رقم التليفون : 01158544005
العنوان : شبرا
العمر (تاريخ الميلاد) : 22-01-1956 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فوزيه شاذلي خلف الله حسن National ID: 25601220103984	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

دوستاف
زوسبي
٨٨



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

المنشأة المصرية
MDT FORM

09/22/2026

MDT FORM

Name:	فوزية مائلى خلف الله حسن	MRN:	12079
Age:	71 Y	ID:	25601220103984
Menopausal Sta	POST MENOPASUAL	Phone:*	01158544005
NRS SCORE:		Marital Status:	WIDOW
BMI:		Family History:	FREE
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity:	htn	Post op	
Surgical History:*	APPENDICECTOMY	ECOG Performance Status	0 1 2 3 4

Clinical Data:

BX: INVASIVE DUCT CARCINOMA

ER: 8/8 PR: 7/8 HER2: 1+ KI67: 25%

History:

ptn underwent rt MRM
POP :
IDC with lobular differentiation G11
ALND :1/18 without extranodal extension

T2 N1a

Sonomammography:

ACR B
11 OCLOCK MASS 1,9X 1,5 CM
12 OCLOCK MASS 1,5 X 1,4 CM
DISTANCE BETWEEN THEM 5 MM
DILATED RETROAREOLAR DUCTS 4 MM INTRADUCTAL EXTENSION
NONSPECIFIC AXILLARY LNS

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

CAP LYTIC LESIONS
BONE SCAN FREE

Recommendations:

for possibility of adjuvant tit

MDT Outcome & Plan

Portacath
4 Docetaxel - Endoxan
PORT
Femara x 7 years + zometa / 6months

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د. خالد عبد العزيز	محمد تيرادي		

7/27/26, 10:21 AM

MDT Form

code:09 -- Name_A MDT FORM -- Name_E MDT FORM

مستشفى
الشيخ زايد
الرياضC.P.L.
7/1/26مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصريةالمستشفى
الرياض

07/27/2026

□

MDT FORM

Name:	لورين ديفيد جاك م. جين	MRN:	12079
Age:	71 Y	ID:	25601220103984
Menopausal Sta	POST MENOPASUAL	Phone:*	01158544005
NRS SCORE:		Marital Status:	WIDOW
BMI:	0	Family History:	FREE
Gender		Reason Of MDT:	NEW
CO Morbidity:	HYPERTENSIVE		
Surgical History:*	APPENDICECTOMY	ECOG Performance Status	0 10 20 30 4

Clinical Data:

BX: INVASIVE DUCT CARCINOMA

ER: 8/8 PR: 7/8 HER2: 1+ KI67: 25%

History:

Sonomammography:

ACR B
11 OCLOCK MASS 1,9X 1,5 CM
12 OCLOCK MASS 1,5 X 1,4 CM
DISTANCE BETWEEN THEM 5 MM
DILATED RETROAREOLAR DUCTS 4 MM INTRADUCTAL EXTENSION
NONSPECIFIC AXILLARY LMS
Biomarker/Molecular

Mets Workup:

CAP LYTIC LESIONS

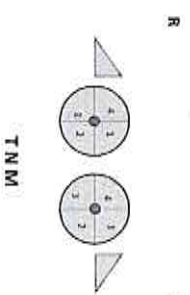
BONE SCAN FREE

Recommendations:

FOR UPFRONT RT SM + SLNB

MDT Outcome & Plan

luminal type cT2n0 for upfront surgery RT SM+SLND



Clinical Staging:

T2N0

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
م. ك. ك.			



N H I

قسم الباثولوجي

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: فوزيه شاذلي خلف الله Age: years Sex: female

Request type: مبرر Sub request type:

Hospital no: Pathology no.: 515B-2026

Department: وحدة مرأى Date of result:

Referred by: د/ايمن علل Date of biopsy: 17/6/2026

Nature of specimen: tru-cut biopsy I.D. Number: 25601220103984

Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology :

multiple gray white tissue cores measured 1cm, totally submitted

Immunohistochemical Technique: Sections were prepared from the paraffin block,

processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain.

The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:

Section examined revealed breast core tissue showed clusters, nest and cribriform pattern of anaplastic ductal cells with moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules dispersed among desmoplastic stroma with mild lymphocytic response.

Immunohistochemical Result:

ER: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Moderate nuclear staining of 90% of tumor cells (Allred Score 7/8).

Her2: Moderate incomplete membranous staining of > 10% tumor cells (score1+) Her2

low

Ki67: Positive nuclear staining of 25% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass: Tru Cut Biopsy:

Invasive Duct Carcinoma (NST), Grade II

Signature:

Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

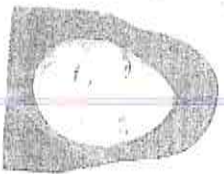


٢٠٢٤/٨ ٢٥٦٠١٢٢-١-٣٩٨٤
البلقة سارية حتى
٢٠٣١/٠٩/١٣
أرملة
مسلمة
الجنس



ع ٤
٢٥٦/٢/٢
C. ٢٥٦/٢/٢

مسلمة



فرزیه
شمالی خلف الله حسن
مجازرة ١٩١٠ مجموعة ١٠
خمسة عشر مايو - القالدة

٢٥٦٠١٢٢٠١٣٩٨٤

KT2187890

Patient ID: 96286	Patient Name English: Fawziah Shazil Anwar Ruzh
Year: 2026, Date: 06/15, Age:	2026/06/15 11:59:41 AM : Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 70 years old female patient with right breast lump.

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The right breast shows two variable sized and shape adjacent middle 1/3 upper central/outer quadrat ill-defined dense mass lesions, the posterior one is lobulated partially obscured margins and the anterior one shows speculated margins, about 3 cm from the nipple.

Ultrasound revealed:

- One rather well defined heterogeneous mass lesion at 12 o'clock position measures about 1.5 x 1.4 cm and about from 0.5 cm the overlying skin.
- The other one is seen at 11 o'clock position being ill-defined hypochoic with speculated margins measures about 1.9 x 1.5 cm and about 1.1 cm from the skin.
 - o The distance between the two lesions measures about 5 mm.
- Associated with related dilated retroareolar ducts reaching up to 4 mm?? Irtraductal extension.
- Normal nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Right breast (BIRADS 4C): Right two UOQ highly suspicious mass lesions as described. For Tru cut biopsy.
- Left breast (BIRADS 2): normal study.

Much obliged,
Dr. Ayat Nadi, FRCR

Name : Fawziya Chazli Khalaf Allah Hassan
 Branch : Dokki
 Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Date : 10-07-2026 09:59
 Medical No. : 413074
 التأمين الصحي : Ins.Company :

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

70 year-old female patient , presented with history of right breast cancer and referred for skeletal survey .

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mci of the tracer.

Findings

- No evidence of tracer uptake abnormalities that would account for bone secondaries could be seen.
- Degenerative changes are noticed at different levels of the spine.
- Osteoarthritic features are noted around big joints.

IMPRESSION

- No definite osseous metastases detected on scintigraphic basis.

Much obliged
 Dr. Alaa Nagy, MD
 Nuclear medicine

Patient's Name:

Fawziya Shazly Khalafallah

Date:

2026-07-04

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

MULTISCLICE CT. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS AFTER I.V. CONTRAST INJECTION REVEALED:

I- CHEST:

Right breast is partially out of field.

- Two small right breast lesions measuring 21 x 20 mm and 20 x 17 mm for sonomammography.
- No pulmonary nodules, masses, consolidation, collapse or cavitary lesions.
- Few bilateral scattered fine atelectatic bands.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.
- Enlarged thyroid isthmus showing a hypochoic nodule measuring 43 x 28 mm for sonographic assessment.

I- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing homogenous parenchymal attenuation. No focal lesion or dilated biliary radicles.
- Gall bladder show two tiny stones within.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness, nephrogram and excretory function. No stones or back pressure changes. Small left renal cortical cyst.
- Normal C.T appearance of the spleen, adrenal glands, pancreas, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

II- BONY SKELETON:

- Two tiny D6 and L3 vertebral bodies lytic foci.

OPINION:

- No pulmonary or hepatic metastatic lesions.

Dr.sherif Wagdy